

COMPASS™ · EDIÇÃO 006/2026

Transição Demográfica e Oftalmologia na Saúde Suplementar: Pressão de Demanda, Custos e Reorganização de um Mercado de R\$ 10 Bilhões

Compass™ — um produto do Grupo CSV •

Responsabilidade editorial: MedValor® • Elaboração: AxiaCare®

Executive Summary

A oftalmologia movimenta anualmente R\$ 10 bilhões na saúde suplementar brasileira, impulsionada por dois vetores irreversíveis:

1. A transição demográfica brasileira altera estruturalmente a base de demanda por serviços oftalmológicos. A população com mais de 65 anos dobrou entre 2000 e 2022 (de 5,84% para 10,92%) e o índice de envelhecimento atingiu 55 idosos para cada 100 crianças. Patologias idade-dependentes (catarata, glaucoma, DMRI) não são escolhas eletivas; são demandas inelásticas que crescem em proporção direta ao envelhecimento da carteira das operadoras [1].
2. A incorporação tecnológica eleva o custo unitário dos procedimentos, especialmente na oftalmologia, onde OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), como lentes intraoculares, e medicamentos de alto custo (antiangiogênicos) representam parcelas crescentes da despesa assistencial. A combinação de maior frequência (demanda demográfica) com maior severidade (custo unitário tecnológico) cria uma pressão financeira que o modelo tradicional de *fee for service* é incapaz de conter [1].

A reorganização do mercado ocorre em três frentes:

- **Para as operadoras:** A necessidade de conter a sinistralidade impulsiona a busca por modelos de remuneração alternativos, como pacotes e *capitation*, e a verticalização ou o estabelecimento de redes referenciadas de alta eficiência [1].
- **Para os prestadores:** A sobrevivência financeira exige escala, eficiência operacional (aumento do giro de sala) e padronização rigorosa de insumos. A consolidação do setor, liderada por fundos de *private equity*, cria redes oftalmológicas nacionais que diluem custos fixos e aumentam o poder de barganha [1].
- **Para a cadeia de suprimentos:** A pressão por redução de custos altera a dinâmica de negociação de OPME e medicamentos, favorecendo modelos de compartilhamento de risco e acordos de volume direto com fabricantes [1].

1. A Força Demográfica: O Envelhecimento como Motor Inelástico de Demanda

A oftalmologia é uma das especialidades médicas mais sensíveis à estrutura etária da população. Ao contrário de outras áreas onde a demanda pode ser modulada por fatores comportamentais ou epidemiológicos transitórios, a prevalência de doenças oculares graves — como catarata, glaucoma e Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) — apresenta correlação quase perfeita com o avanço da idade.

O Brasil atravessa uma transição demográfica acelerada. Dados do IBGE [2] revelam que a proporção de idosos (65 anos ou mais) na população dobrou em pouco mais de duas décadas, saltando de 5,84% no Censo de 2000 para 10,92% no Censo de 2022. O índice de envelhecimento, que mede a proporção de idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos, subiu de 30,8 em 2010 para 55,2 em 2022.

Na saúde suplementar, que concentra aproximadamente 51 milhões de beneficiários, essa transição é ainda mais pronunciada. A carteira de idosos nas operadoras cresce a taxas superiores à média populacional, pressionando a utilização de serviços oftalmológicos. A catarata, por exemplo, afeta mais de 70% das pessoas acima de 70 anos. O tratamento definitivo é invariavelmente cirúrgico. Não se trata de uma demanda que pode ser evitada por programas de prevenção primária; é uma demanda inelástica que se acumula no topo da pirâmide etária.

1.1. O Impacto Financeiro da Demanda Inelástica

A combinação dessa demanda crescente com a incorporação contínua de novas tecnologias (lentes intraoculares premium, equipamentos a laser de precisão, terapias antiangiogênicas) cria uma espiral de custos. Estima-se que o mercado oftalmológico na saúde suplementar movimente R\$ 10 bilhões anualmente [1]. Desse montante, uma fatia desproporcional é consumida por procedimentos de alta complexidade e materiais especiais.

VETOR DE PRESSÃO	IMPACTO NO MERCADO OFTALMOLÓGICO
Transição Demográfica	Aumento exponencial da prevalência de catarata, glaucoma e DMRI. Demanda inelástica por procedimentos cirúrgicos e terapias crônicas.
Incorporação Tecnológica	Elevação do custo unitário por procedimento (novas lentes, equipamentos, drogas antiangiogênicas).
Modelo <i>Fee for Service</i>	Incentivo à superutilização e repasse integral da ineficiência e variação de insumos para a operadora.

Para as operadoras, a oftalmologia deixou de ser uma linha de custo secundária e passou a figurar entre os principais ofensores da sinistralidade cirúrgica ambulatorial. A incapacidade de prever e controlar essa despesa no modelo tradicional de *fee for service* força uma revisão estrutural na forma como os serviços são contratados e remunerados.

2. A Reação das Operadoras: Do *Fee for Service* aos Modelos Baseados em Valor

A resposta imediata das operadoras à pressão de custos oftalmológicos foi a intensificação das ferramentas tradicionais de controle: glosas, restrição de rede e auditorias rigorosas. No entanto, essas medidas atuam apenas sobre a frequência (tentando coibir procedimentos desnecessários), mas falham em controlar a severidade (o custo de cada procedimento realizado), especialmente quando o modelo de remuneração subjacente permanece o *fee for service*.

A reorganização do mercado oftalmológico passa necessariamente pela transição para modelos de remuneração que alinhem os incentivos entre pagadores e prestadores. Três movimentos principais se destacam:

2.1. Pacotização de Procedimentos Cirúrgicos

A cirurgia de catarata, por seu alto volume e previsibilidade clínica, é o candidato ideal para a pacotização. No modelo de pacote, a operadora remunera o prestador com um valor fixo que engloba honorários médicos, taxas de sala, medicamentos e, crucialmente, a lente intraocular (OPME). Essa transferência de risco obriga o prestador a buscar eficiência operacional e a padronizar insumos. Como demonstrado na edição 005 do Compass™, a padronização de OPME é responsável por até 66% do saving estrutural em pacotes cirúrgicos.

2.2. Verticalização e Redes Referenciadas

Para obter controle total sobre a jornada do paciente e os custos associados, algumas operadoras optam pela verticalização, construindo clínicas e centros cirúrgicos oftalmológicos próprios. Quando a verticalização não é viável, a estratégia é o estabelecimento de redes referenciadas estreitas: a operadora direciona o volume de pacientes para um número reduzido de prestadores de alta eficiência em troca de tabelas de remuneração mais vantajosas (pacotes ou *capitation*).

2.3. Gestão Populacional (*Capitation*)

Embora ainda incipiente na oftalmologia brasileira, o modelo de *capitation* — onde o prestador recebe um valor fixo mensal por beneficiário para cobrir todas as necessidades oftalmológicas de uma população definida — representa o estágio mais avançado de alinhamento de incentivos. Nesse modelo, o prestador lucra ao manter a população saudável e ao resolver os problemas de forma resolutiva e eficiente, evitando o sobretratamento inerente ao *fee for service*.

3. A Reorganização dos Prestadores: Escala, Eficiência e Consolidação

Do lado dos prestadores (clínicas e hospitais oftalmológicos), a transição demográfica e a pressão das operadoras por modelos de pacotes exigem uma reestruturação profunda do modelo de negócios. A clínica oftalmológica tradicional, fragmentada e ineficiente, não sobrevive em um ambiente de margens comprimidas.

3.1. A Busca por Escala e a Onda de Consolidação

O mercado oftalmológico brasileiro é altamente fragmentado, composto por milhares de clínicas de pequeno e médio porte. No entanto, a necessidade de investir em tecnologia de ponta (equipamentos a laser caros) e de ganhar poder de barganha junto a fornecedores de OPME e operadoras tem impulsionado uma forte onda de consolidação. Fundos de *private equity* e grandes grupos de saúde têm adquirido e integrado clínicas, formando redes nacionais.

A escala permite:

- **Diluição de custos fixos:** O custo de um equipamento de última geração é diluído por um volume muito maior de procedimentos.
- **Poder de negociação com fornecedores:** Redes consolidadas negociam compras diretas de lentes intraoculares e medicamentos com os fabricantes, eliminando intermediários e reduzindo o custo do OPME, o que é fundamental para a rentabilidade em modelos de pacotes.
- **Poder de negociação com operadoras:** Grandes redes têm capilaridade e volume para negociar contratos baseados em valor ou pacotes com operadoras de âmbito nacional.

3.2. Eficiência Operacional como Diferencial Competitivo

Em um modelo de pacote, onde a receita é fixa, a margem de lucro é determinada exclusivamente pelo custo de produção. A eficiência operacional do centro cirúrgico oftalmológico torna-se a principal alavanca de resultado. Isso implica maximizar o giro de sala (número de cirurgias por hora), minimizar o tempo de *setup* entre procedimentos e padronizar rigorosamente os insumos utilizados.

Clínicas oftalmológicas de alta performance operam como verdadeiras "fábricas de cirurgias", onde cada etapa da jornada do paciente é mapeada e otimizada para garantir o menor custo unitário sem comprometer a qualidade clínica.

4. Conclusão

A oftalmologia na saúde suplementar brasileira não é mais apenas uma especialidade médica; é um mercado de R\$ 10 bilhões em profunda reestruturação. A transição demográfica garante que a demanda por serviços oftalmológicos continuará crescendo de forma inelástica nas próximas décadas. Para as operadoras, a sobrevivência financeira exige a superação do *fee for service* e a adoção de modelos que transfiram o risco de severidade para os prestadores. Para os prestadores, a consolidação, a escala e a eficiência operacional extrema são os únicos caminhos para manter a lucratividade em um cenário de pacotização e margens comprimidas.

5. Referências

NOTAS	FONTE	URL
[1] Oftalmologia no Brasil: o mercado de R\$ 10 bilhões que o envelhecimento vai reorganizar.	Evodux Intelligence, 31 de maio de 2026.	Link
[2] Censo Demográfico 2022.	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2023.	

Nota de Escopo: Cada edição do Compass™ é um documento técnico-estratégico de uso interno, destinado à educação continuada e ao apoio à tomada de decisão dos integrantes do Grupo CSV. Quando o tema envolver aspectos jurídicos, regulatórios ou contratuais, recomenda-se avaliação complementar por profissional especializado.